TAJNÝ BONUS

Hlášení kritického nálezu: Jak jej sdělit po telefonu

Našli jste kritický nález; nyní jej musíte po telefonu sdělit do 30 sekund, kompletně a bez nedorozumění. Struktura Situace · Anamnéza · Hodnocení · Doporučení, 12 připravených rozhovorů a co zaznamenat do popisu.

Obsah

Co je kritický nález a proč volat?

Čtyřkrokový rozhovor: Situace · Anamnéza · Hodnocení · Doporučení

Před hovorem a po něm

12 vzorových telefonických hlášení

Co se zaznamenává do popisu

Obtížné situace

Další krok

KAPITOLA 1

Co je kritický nález a proč volat?

Poslední článek kroku SHRŇTE: nahlaste urgentní nález.

> *Práce nekončí odesláním popisu do systému, ale ve chvíli, kdy se o nálezu dozví správný lékař.*

Kritický nález je nález, který může při absenci okamžitého zásahu ohrozit život pacienta nebo funkci orgánu. O tom, které nálezy se hlásí telefonicky, rozhoduje seznam vašeho pracoviště; níže jsou uvedeny příklady často zařazované do těchto seznamů.

Neuro a páteř

Intrakraniální krvácení · expanzivní chování a herniace · známky akutního iktu · akutní hydrocefalus · komprese míchy · nestabilní fraktura páteře

Hrudník

Pneumotorax se známkami tenze · plicní embolie · disekce aorty · chybná poloha kanyly nebo katétru · podezření na tamponádu

Břicho a pánev

Volný vzduch · obstrukce se známkami ischémie · AAA se známkami ruptury · aktivní krvácení · ektopická gravidita · torze varlete nebo ovaria

Pediatrie a ostatní

Invaginace · cizí těleso nebo knoflíková baterie v jícnu · jakýkoli neočekávaný nález měnící klinické rozhodnutí

Vaše pravidlo jakožto rezidenta

Pokud si nejste jisti, zda je nález kritický, nahlaste jej a poraďte se se svým školitelem. Postup hlášení vašeho oddělení má před tímto materiálem přednost.

KAPITOLA 2

Čtyřkrokový rozhovor

Český ekvivalent struktury SBAR: Situace · Anamnéza · Zhodnocení · Doporučení.

KROK	CO ŘEKNETE	VZOR
S · Situace	Kdo jste, jaký pacient, nejdůležitější nález — v jedné větě.	«Rezident radiologie [vaše jméno]. U [jméno pacienta, číslo protokolu] je na [vyšetření] přítomen [nález].»
A · Anamnéza	Proč a kdy bylo vyšetření provedeno; klinická otázka v žádance.	«Provedeno v [čas] pro [klinický stav]; žádanka «[otázka]».»
H · Hodnocení	Závažnost nálezu: velikost, expanzivní chování, změna oproti předchozímu vyšetření.	«[Rozměr/stupeň]; na předchozím vyšetření [nebylo/bylo].»
D · Doporučení	Co očekáváte a žádost o zpětné přečtení.	«Doporučuji [urgentní zhodnocení / doplňující vyšetření]. Můžete to zpětně přečíst?»

Identifikace pacienta: dva identifikátory

Na začátku hovoru uveďte pacienta alespoň dvěma identifikátory (jméno, příjmení a číslo chorobopisu nebo datum narození). Podobná jména pacientů jsou nejčastější příčinou záměny.

Zpětné přečtení

Požádejte druhou stranu o zopakování nálezu a identifikace pacienta. Zpětné přečtení je nejjednodušší způsob, jak po telefonu předejít záměně stran a pacientů.

KAPITOLA 3

Před hovorem a po něm

Před zvednutím telefonu 30 sekund přípravy, po položení minuta na záznam.

Před telefonátem

- [ ] Identifikace pacienta a vyšetření jsou otevřeny na vaší obrazovce.
- [ ] Byl identifikován indikující lékař nebo lékař aktuálně zodpovědný za pacienta.
- [ ] Nález, strana a rozměry byly zapsány na papír nebo do konceptu popisu.
- [ ] Předchozí vyšetření zkontrolováno (nové, nebo již známé?).
- [ ] V případě potřeby byl informován váš školitel.

Po zavěšení

- [ ] Telefonické hlášení zaznamenáno v popisu: čas, komu (funkce, oddělení), jakým způsobem.
- [ ] Bylo zaznamenáno provedení zpětného přečtení.
- [ ] Pokud má vaše pracoviště systém pro evidenci kritických nálezů, bylo to zadáno i tam.
- [ ] Popis byl bez prodlení zadán do systému.

KAPITOLA 4

12 vzorových telefonických hlášení

Vyplňte hranaté závorky; přizpůsobte věty svému mluvenému projevu, dodržte pořadí.

01 Nálezy svědčící pro tenzní pneumotorax

Lůžkový RTG hrudníku, JIP.

S · SITUACE	Radiologický rezident [vaše jméno]. [Lůžko/oddělení] váš pacient [jméno pacienta, číslo protokolu] u [čas] na pořízeném RTG hrudníku [vpravo] vidím rozsáhlý pneumotorax a přetlačení mediastina na kontralaterální stranu.
A · ANAMNÉZA	Pacient [intubován/po intervenci]; indikace «[otázka na žádance]».
H · HODNOCENÍ	Nález svědčí pro tenzní pneumotorax. Na předchozím snímku pneumotorax [nebylo].
D · DOPORUČENÍ	Doporučuji pacienta neprodleně zhodnotit. Můžete nález zpětně přečíst?

Záznam do popisu: «[Vpravo] rozsáhlý pneumotorax a radiologické známky svědčící pro tenzní pneumotorax. [Čas] v [funkce, oddělení] telefonicky hlášeno ošetřujícímu lékaři, informace potvrzena zpětným přečtením.»

02 Akutní epidurální hematom

Trauma hlavy, urgentní příjem, nekontrastní CT mozku.

S · SITUACE	Radiologický rezident [vaše jméno]. Na urgentním příjmu [jméno pacienta, číslo protokolu] na CT mozku [pravá temporální] je přítomen akutní epidurální hematom.
A · ANAMNÉZA	Provedeno po traumatu hlavy; žádanka «krvácení?»
H · HODNOCENÍ	Nejširší místo [.. mm], posun střední čáry [.. mm]; na [lineární fraktura] je přítomno.
D · DOPORUČENÍ	Může být nutné urgentní neurochirurgické zhodnocení; popis právě zadávám do systému.

Záznam do popisu: «[Pravá temporální] akutní epidurální hematom, [.. mm] přesun středočárových struktur. [Čas] urgentní příjem [funkce] telefonicky hlášeno ošetřujícímu lékaři; provedeno zpětné přečtení.»

03 Subarachnoidální krvácení

Náhle vzniklá prudká bolest hlavy, nativní CT mozku.

S · SITUACE	Radiologický rezident [vaše jméno]. [Jméno pacienta, číslo protokolu] vidím na CT mozku subarachnoidální krvácení.
A · ANAMNÉZA	Provedeno pro náhle vzniklou bolest hlavy; úraz v anamnéze [není].
H · HODNOCENÍ	Krvácení [v bazálních cisternách] rozsáhlé; hydrocefalus [není/je].
D · DOPORUČENÍ	K posouzení aneuryzmatu doporučuji CT angiografii; prosím o konzultaci s příslušným pracovištěm.

Záznam do popisu: «Subarachnoidální krvácení; doporučena CT angiografie. [Čas] v [funkce, oddělení] hlášeno ošetřujícímu lékaři.»

04 Akutní ischemická cévní mozková příhoda · hyperdenzní MCA

Iktový kód, nativní CT mozku.

S · SITUACE	Radiologický rezident [vaše jméno]. V iktovém protokolu [jméno pacienta, číslo protokolu] na CT není krvácení; [vlevo] V MCA je přítomen příznak hyperdenzní arterie a známky časné ischemie.
A · ANAMNÉZA	Začátek symptomů v žádance [čas] uvedeno jako.
H · HODNOCENÍ	Krvácení neprokázáno; [vlevo] Časné ischemické změny v povodí MCA.
D · DOPORUČENÍ	Doporučuji zhodnocení pomocí CT angiografie. Můžete mi nález zopakovat pro kontrolu?

Záznam do popisu: «Intrakraniální krvácení nepřítomno; [vlevo] Příznak hyperdenzní arterie a známky časné ischemie v MCA. V rámci iktového protokolu [čas] v [funkce, oddělení] hlášeno ošetřujícímu lékaři.»

05 Plicní tromboembolie

CT plicní angiografie, lůžkový pacient.

S · SITUACE	Radiologický rezident [vaše jméno]. [Oddělení] váš pacient [jméno pacienta, číslo protokolu] je na CT plicní angiografii přítomna bilaterální plicní embolie.
A · ANAMNÉZA	Indikováno pro dušnost a tachykardii.
H · HODNOCENÍ	Embolie [lobární a segmentální] úrovni; známky přetížení pravé komory [přítomen/nepřítomen].
D · DOPORUČENÍ	Doporučuji zhodnotit pacienta; popis je v systému.

Záznam do popisu: «Bilaterální akutní plicní tromboembolie; známky přetížení pravé komory [přítomen/nepřítomen]. [Čas] v [funkce, oddělení] telefonicky hlášeno ošetřujícímu lékaři.»

06 Disekce aorty

Bolest na hrudi a v zádech, CT angiografie.

S · SITUACE	Radiologický rezident [vaše jméno]. Na urgentním příjmu [jméno pacienta, číslo protokolu] je na CT angiografii disekce aorty; do vzestupné aorty [postižen/nepostižen].
A · ANAMNÉZA	Indikováno pro náhle vzniklou bolest na hrudi a v zádech.
H · HODNOCENÍ	Disekce [z ascendentní aorty] začínající [úroveň] sahá k; perikardiální výpotek [není/je].
D · DOPORUČENÍ	Může být nutné urgentní kardiochirurgické zhodnocení; můžete mi nález zopakovat pro kontrolu?

Záznam do popisu: «[Stanford A] disekce aorty. Urgentní nález; [čas] urgentní příjem [funkce] hlášeno ošetřujícímu lékaři, potvrzeno zpětným přečtením.»

07 Pneumoperitoneum

Náhlá příhoda břišní, RTG hrudníku vstoje / CT břicha.

S · SITUACE	Radiologický rezident [vaše jméno]. [Jméno pacienta, číslo protokolu] na vyšetření vidím volný vzduch pod bránicí.
A · ANAMNÉZA	Indikováno pro bolesti břicha; na žádance nedávná chirurgická anamnéza [neuvedeno].
H · HODNOCENÍ	Volný vzduch [bilaterálně]; na CT pravděpodobné místo perforace [lokalizace].
D · DOPORUČENÍ	Doporučuji urgentní chirurgické zhodnocení. Je v anamnéze nedávný chirurgický nebo intervenční výkon?

Záznam do popisu: «Pneumoperitoneum; svědčí pro perforaci dutého orgánu. [Čas] v [funkce, oddělení] telefonicky hlášeno ošetřujícímu lékaři.»

08 Chybná poloha nazogastrické sondy

Snímek u lůžka před zahájením výživy.

S · SITUACE	Radiologický rezident [vaše jméno]. [Lůžko/oddělení] váš pacient [jméno pacienta, číslo protokolu] na kontrolním RTG snímku NG sondy je její konec [pravý hlavní bronchus] v projekci.
A · ANAMNÉZA	Před zahájením výživy požadována kontrola polohy sondy.
H · HODNOCENÍ	Kanyla není ve správné poloze; [bez pneumotoraxu].
D · DOPORUČENÍ	Doporučuji upravit polohu kanyly před jejím použitím. Můžete nález přečíst zpět?

Záznam do popisu: «Konec nazogastrické sondy [pravý hlavní bronchus] v projekci, není ve správné poloze. Před použitím [čas] v [funkce, oddělení] hlášeno ošetřujícímu lékaři / sestře.»

09 Torze varlete

Náhlá bolest skrota, Doppler UZ skrota.

S · SITUACE	Radiologický rezident [vaše jméno]. [Jméno pacienta, číslo protokolu] na dopplerovském UZ skrota [vlevo] ve varleti není patrný průtok.
A · ANAMNÉZA	Indikováno pro náhle vzniklou bolest skrota; začátek [čas].
H · HODNOCENÍ	Nález odpovídá torzi; druhostranné varle je normální.
D · DOPORUČENÍ	Doporučuji urgentní urologické zhodnocení.

Záznam do popisu: « [Vlevo] nález svědčící pro torzi varlete. Urgentní nález; [čas] v [funkce, oddělení] telefonicky hlášeno ošetřujícímu lékaři.»

10 Nálezy svědčící pro ektopickou graviditu

Pozitivní těhotenský test, UZ pánve.

S · SITUACE	Radiologický rezident [vaše jméno]. [Jméno pacienta, číslo protokolu] na pánevním UZ nevidím intrauterinní graviditu; [vpravo] je přítomna adnexální rezistence a volná tekutina.
A · ANAMNÉZA	Pozitivní těhotenský test, indikováno pro bolesti v pánvi.
H · HODNOCENÍ	Nálezy svědčí pro mimoděložní těhotenství; volná tekutina [s echogenním obsahem].
D · DOPORUČENÍ	Doporučuji urgentní gynekologické zhodnocení. Můžete mi nález přečíst zpět pro kontrolu?

Záznam do popisu: «Intrauterinní gravidita nezobrazena; [vpravo] nálezy svědčící pro ektopickou graviditu s adnexální rezistencí a volnou tekutinou. [Čas] v [funkce, oddělení] hlášeno ošetřujícímu lékaři.»

11 Komprese míchy

Známá malignita, bolest v zádech, MR hrudní páteře.

S · SITUACE	Radiologický rezident [vaše jméno]. [Jméno pacienta, číslo protokolu] na MR hrudníku [T..] v úrovni je přítomna komprese míchy.
A · ANAMNÉZA	Indikováno pro známou malignitu a nově vzniklou bolest v zádech.
H · HODNOCENÍ	Útlak může odpovídat epidurálnímu šíření tumoru; změna signálu v míše [přítomen/nepřítomen].
D · DOPORUČENÍ	Doporučuji urgentní zhodnocení; kompletní zobrazení páteře [provedeno/může být nutné].

Záznam do popisu: «[T..] v úrovni léze kompatibilní s epidurálním šířením tumoru a komprese míchy. [Čas] v [funkce, oddělení] telefonicky hlášeno ošetřujícímu lékaři.»

12 Invaginace (dítě)

Intermitentní bolesti břicha, UZ břicha.

S · SITUACE	Radiologický rezident [vaše jméno]. Na dětském urgentním příjmu [jméno pacienta, číslo protokolu] na UZ břicha [ileokolický] vidím invaginaci.
A · ANAMNÉZA	Indikováno pro intermitentní bolesti břicha a zvracení.
H · HODNOCENÍ	[V pravé polovině břicha] obraz terče; tok ve stěně [zachováno/sníženo], volná tekutina [není/je].
D · DOPORUČENÍ	Doporučuji urgentní dětské chirurgické zhodnocení.

Záznam do popisu: «[Ileokolický] nález svědčící pro invaginaci. Urgentní nález; [čas] v [funkce, oddělení] hlášeno ošetřujícímu lékaři.»

KAPITOLA 5

Co se zaznamenává do popisu

Nezaznamenané hlášení nelze zpětně ověřit.

POLOŽKA	PŘÍKLAD
Co bylo nahlášeno	Kritický nález v závěru, stejnými slovy jako v popisu.
Čas	«v [čas]» — pokud datum nevyplývá ze samotného popisu, uveďte i datum.
Komu	Funkce a oddělení: «sloužící lékař urgentního příjmu», «vedoucí lékař [oddělení]». Uvedení jména závisí na zvyklostech vašeho pracoviště.
Jakým způsobem	Telefonicky / osobně.
Potvrzení	«Informace byla potvrzena zpětným přečtením.»

Vzor záznamové věty

«[Nález]. V [čas] telefonicky hlášeno lékaři [titul, oddělení], informace potvrzena zpětným přečtením.»

KAPITOLA 6

Obtížné situace

Telefon není vždy zvednut na první zavolání.

SITUACE	CO UDĚLÁTE
Nemůžete zastihnout indikujícího lékaře	Spojte se s lékařem aktuálně odpovědným za pacienta nebo se sloužícím lékařem oddělení; postupujte podle eskalačního řádu vašeho pracoviště. Zaznamenejte pokusy a jejich časy; informujte svého školitele.
Druhá strana o nálezu již ví	Přesto stručně nahlaste a zaznamenejte jako «potvrzeno jako známý nález»; zvláště uveďte změnu oproti předchozímu vyšetření.
Nejste si nálezem jisti	Neodkládejte hlášení; ihned se poraďte se svým školitelem. Míru jistoty uveďte jasně i po telefonu: «svědčí pro», «suspektní».
Hovor se protahuje nebo přechází v hádku	Vraťte se ke čtyřem krokům, zopakujte doporučení a zapojte svého školitele. Klinické rozhodnutí náleží klinickému týmu; vaším úkolem je předat nález správně a včas.
Předběžný popis v noční službě	Kritický nález se stejným způsobem hlásí a zaznamenává i v předběžném popisu; pokud po definitivním popisu dojde ke změně, hlásí se znovu.

Vzdělávací účely. Tento materiál nenahrazuje předatestační přípravu, odborný dohled, klinický úsudek ani popis specialisty.

Další krok

Nyní se vraťte k: Hlavní materiál · 120 šablon hotových popisů. Formulace hlášení v poli Závěr u šablon kritických nálezů vyplňte podle záznamového vzoru v této kapitole.

Pro všechny závěry popisu u kritických nálezů **Bonus 1 · Databanka 200 závěrů popisu** se můžete podívat na formulace s označením «Urgentní».